

TEMA 7.5 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Psiquiatría Adultos: Generalidades y Clasificación

PERFIL EUNACOM 1.09.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Salud Mental en la Práctica Médica

El estudio de la psiquiatría y la salud mental es fundamental para el médico general en Chile por diversas razones que impactan directamente en el sistema de salud:

- **Somatización:** Es una causa frecuente de consulta. Muchos pacientes acuden por síntomas orgánicos (cefalea, dolor abdominal, mialgias) que, tras el estudio correspondiente, revelan una patología de salud mental subyacente.
- **Impacto Socioeconómico:** Las patologías de salud mental representan cerca del **30% del costo y volumen de las licencias médicas** en Chile. El ausentismo laboral por **Depresión** o estrés laboral es un desafío mayor para la salud pública.
- **Sufrimiento Humano:** Más allá de lo económico, estas patologías generan un sufrimiento profundo en el paciente y su red de apoyo, llegando a ser altamente invalidantes.
- **Reducción del Estigma:** Un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado (como en el **Trastorno Bipolar**) pueden permitir que un paciente sea plenamente funcional, eliminando prejuicios históricos.

Esquema General de Clasificación de Trastornos Psiquiátricos

Para enfrentar el examen y la práctica clínica, es útil organizar las patologías en grandes grupos según su síntoma predominante:

TABLA 7.5.1: GRUPO DE TRASTORNO VS PATOLOGÍAS PRINCIPALES		
GRUPO DE TRASTORNO	PATOLOGÍAS PRINCIPALES	SÍNTOMA GUÍA
Trastornos del Ánimo	Depresión, Trastorno Bipolar, Distimia, Trastorno adaptativo.	Alteración patológica del humor (tristeza o euforia).
Trastornos Psicóticos	Esquizofrenia, Trastorno delirante, Trastorno esquizoafectivo, Psicosis aguda.	Pérdida del juicio de realidad.
Trastornos Ansiosos	Trastorno de Pánico, Trastorno de Ansiedad Generalizada, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Fobias, Trastorno de Estrés Postraumático.	Miedo, ansiedad o angustia patológica.
Trastornos Somatomorfos	Trastorno de somatización, Hipocondría, Trastorno conversivo, Trastorno por dolor.	Síntomas físicos sin causa orgánica explicable.
Trastornos de la Alimentación	Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa.	Alteración de la conducta alimentaria y percepción corporal.
Trastornos Disociativos	Amnesia y fuga disociativa, Despersonalización, Desrealización.	Desconexión de la realidad como mecanismo ante el estrés.
Abuso de Sustancias	Alcoholismo, tabaquismo, adicción a drogas.	Consumo perjudicial y dependencia.
Trastornos de Personalidad	Paranoide, Esquizoide, Límitrofe (Borderline), Obsesivo-Compulsivo de la personalidad (TOCP).	Patrones de conducta y relación disfuncionales y rígidos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Diferencia clave para el EUNACOM: No confundas el **TOC** (Trastorno Ansioso con obsesiones y compulsiones que el paciente reconoce como absurdas - egosintónico/egodistónico) con el **Trastorno de Personalidad Obsesivo-Compulsivo** (una forma de ser rígida y perfeccionista).

Manuales Diagnósticos: DSM y CIE

- Existen dos marcos de referencia principales para establecer criterios diagnósticos:
- **DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders):** Actualmente en sus versiones DSM-IV y **DSM-5**. Es de origen estadounidense.
- **CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades):** Publicado por la OMS (CIE-10 y CIE-11).

NOTA CLÍNICA
Para el EUNACOM, **no es necesario memorizar los criterios exactos** (número de síntomas o meses requeridos) de cada manual. Lo fundamental es reconocer la **clínica clásica** y saber diferenciar una patología de otra, ya que los casos clínicos del examen a veces no cumplen estrictamente todos los criterios temporales pero mantienen el patrón típico.

Conceptos Fundamentales: Psicosis vs. "Neurosis"

Aunque el término "neurosis" está técnicamente obsoleto en los manuales modernos, clínicamente se sigue utilizando para diferenciar a los pacientes que mantienen el juicio de realidad de los que no.

1. Psicosis (Pérdida del juicio de realidad)

Se define por la presencia de: - **Delirios:** Ideas falsas, irreductibles a la lógica, que el paciente sostiene con convicción absoluta. - **Alucinaciones:** Percepciones sensoriales sin objeto real (escuchar voces, ver sombras). - **Alteraciones graves del comportamiento:** Conductas desajustadas o extrañas (ej. comer tierra, agitación psicomotora extrema).

2. "Neurosis" (Juicio de realidad conservado)

Incluye a la mayoría de los trastornos (ansiosos, depresivos leves, somatomorfos). El paciente puede sufrir mucho, pero entiende qué es real y qué no.

PERLA CLÍNICA EUNACOM
¿Cómo identificar la Psicosis en el examen? Busca el **pensamiento apodíctico**: el paciente no entiende razones ni argumentos. - *Ejemplo No Psicótico (Hipocondría):* "Creo que tengo cáncer, tengo miedo, pero si la endoscopia sale normal, me quedo tranquilo". - *Ejemplo Psicótico (Delirio Somático):* "Tengo cáncer, y aunque la endoscopia diga que no, yo sé que los médicos están mintiendo y mi cuerpo se está pudriendo".

Descompensantes y Complicaciones

Descompensantes

El factor número uno es el **estrés**. Cualquier patología de salud mental (desde una psicosis hasta un trastorno de personalidad) puede agravarse ante situaciones estresantes. Otros factores incluyen el consumo de drogas y ciertos fármacos.

Complicaciones (Comorbilidad)

Es regla general que los trastornos psiquiátricos se compliquen entre sí: - Los **Trastornos Ansiosos** suelen complicarse con

Depresión. - La **Depresión** puede complicarse con síntomas ansiosos o, en casos graves, con **psicosis** (Depresión Psicótica).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente con diagnóstico previo de depresión comienza con ideas delirantes de culpa o ruina, el diagnóstico actual es **Depresión Psicótica**. La psicosis es la complicación, pero la base sigue siendo el trastorno del ánimo.

Nociones de Psicoterapia y Psicofarmacología

El manejo integral suele combinar fármacos y psicoterapia. Como médicos, debemos conocer los enfoques para derivar correctamente:

- **Psicoterapia Cognitivo-Conductual (TCC):**
- - **Enfoque:** "Conozca y actúe". Identifica pensamientos disfuncionales y modifica conductas.
- - **Ventajas:** Es rápida, estructurada y de primera línea para la mayoría de los trastornos ansiosos y depresivos.
- **Psicoterapia Psicodinámica (Psicoanálisis):**
- - **Enfoque:** Relaciones interpersonales y procesos inconscientes.
- - **Ventajas:** Cambios profundos y sostenibles, pero es un proceso lento y costoso.
- **Psicoterapia Sistémica (Familiar):**
- - **Enfoque:** Interviene en la red de apoyo (familia o amigos).
- - **Indicación clave:** Es la ideal en **niños y adolescentes**, donde el entorno es determinante en la patología.

El Rol del Médico: Psicoeducación

Independientemente de quién realice la psicoterapia, el médico SIEMPRE debe realizar **psicoeducación**: - Explicar la enfermedad al paciente y su familia. - Fomentar la **adherencia al tratamiento** farmacológico. - Advertir sobre riesgos de recidiva y efectos del consumo de alcohol/drogas. - Enseñar a identificar signos de descompensación temprana.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 45 años refiere estar seguro de que tiene cáncer de estómago. Se le realizó endoscopia que fue normal, pero insiste: "Los médicos se equivocaron, yo sé que tengo cáncer aunque los exámenes digan que no". No acepta ningún argumento. ¿Cuál es el elemento semiológico que sugiere psicosis en este caso?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Adultos: Generalidades y Clasificación. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El descompensante más frecuente de todos los trastornos psiquiátricos es el estrés; las drogas y ciertos fármacos también descompensan.
- La psicosis implica pérdida del juicio de realidad; el delirio es el pensamiento apodíctico (certeza absoluta inamovible).
- Los trastornos psiquiátricos se complican más frecuentemente con depresión, ansiedad y psicosis.
- La psicoterapia cognitivo-conductual es la más usada, más rápida y de primera línea para la mayoría de los trastornos psiquiátricos.
- La psicoterapia sistémica es especialmente útil en niños, ya que sus patologías frecuentemente tienen base en la disfunción familiar.
- Reconocer que alguien "puede estar equivocado" sugiere no psicosis; la certeza absoluta (pensamiento apodíctico) es el marcador de psicosis.
- Las patologías psiquiátricas representan más del 30% de los costos de licencias médicas en Chile.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA ADULTOS: GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN)**PREGUNTA 1**

Paciente de 45 años refiere estar seguro de que tiene cáncer de estómago. Se le realizó endoscopia que fue normal, pero insiste: "Los médicos se equivocaron, yo sé que tengo cáncer aunque los exámenes digan que no". No acepta ningún argumento. ¿Cuál es el elemento semiológico que sugiere psicosis en este caso?

- A) El hecho de creer que tiene una enfermedad grave
- B) Que solicite una segunda opinión médica
- C) El pensamiento apodíctico: certeza absoluta que no cede ante evidencia en contrario
- D) Que el médico tenga dificultades para convencerlo
- E) Que tenga antecedentes de ansiedad

PREGUNTA 2

Mujer de 38 años con diagnóstico previo de trastorno de estrés postraumático consulta porque desde hace 2 semanas se siente muy triste, llora frecuentemente y ha bajado 4 kg de peso sin causa aparente. ¿Cuál es el diagnóstico más completo?

- A) Solo trastorno de estrés postraumático, es normal tener estos síntomas
- B) Trastorno adaptativo sobre TEPT previo
- C) TEPT complicado con episodio depresivo mayor
- D) Esquizofrenia de inicio tardío
- E) Trastorno bipolar en fase depresiva

PREGUNTA 3

Médico de APS debe indicar psicoterapia a un paciente con trastorno depresivo mayor. El paciente pregunta qué tipo de psicoterapia es la más recomendada como primera línea. ¿Cuál es la respuesta correcta?

- A) Psicoterapia psicodinámica, porque actúa sobre las causas profundas
- B) Psicoterapia sistémica, porque trabaja la red de apoyo
- C) Psicoterapia cognitivo-conductual, que es la más usada, más rápida y de primera línea
- D) Ninguna psicoterapia; solo antidepresivos son necesarios
- E) Psicoanálisis clásico, porque es el método más validado históricamente

RESUMEN: PSIQUIATRÍA ADULTOS: GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN

Las patologías psiquiátricas son causas frecuentes de consulta médica, ausentismo laboral y sufrimiento individual y familiar. Representan más del 30% de los costos de licencias médicas y son una de las principales fuentes de discapacidad laboral. El conocimiento de la salud mental permite al médico identificar y diferenciar patologías psiquiátricas de causas orgánicas, entre sí, y derivar oportunamente. Los trastornos psiquiátricos se clasifican en: trastornos del ánimo (depresión, trastorno bipolar, distimia, trastorno adaptativo), trastornos psicóticos (esquizofrenia, trastorno delirante, esquizoafectivo), trastornos ansiosos (pánico, TOC, fobia social, TEPT, estrés agudo), trastornos somatomorfos (somatización, hipocondría, dolor, conversivos), trastornos de la alimentación, trastornos disociativos y trastornos de personalidad. Los criterios diagnósticos son los del DSM-4, DSM-5 y CIE, aunque para el EUNACOM importa más reconocer los cuadros clínicos que cumplir criterios. La psicosis implica pérdida del juicio de realidad, cuyos síntomas principales son el delirio (ideas fijas apodícticas fuera de la realidad), las alucinaciones (percepciones sin estímulo) y las graves alteraciones del comportamiento. El pensamiento apodíctico (certeza absoluta inamovible) diferencia una psicosis de una simple creencia errónea. Los descompensantes más frecuentes de todas las patologías psiquiátricas son el estrés, los fármacos y el consumo de drogas. Las complicaciones más frecuentes son depresión, ansiedad y psicosis. La psicoterapia beneficia a todos los trastornos psiquiátricos. Los tres tipos principales son: cognitivo-conductual (la más frecuente y rápida; "conozca y actúe"), psicodinámica (más profunda, trabaja relaciones interpersonales, más lenta y costosa) y sistémica o familiar (interviene la red de apoyo; especialmente útil en niños). La psicoeducación es una responsabilidad del médico general: explicar la enfermedad, el tratamiento y los signos de alerta al paciente y su red.